

TEMA 6.43 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Casos Rinología

PERFIL EUNACOM 4.02.4.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Alergia Otorrinolaringológica a Antibióticos y Resistencia Bacteriana Rústica Asombrosa

El manejo ORL rústico no the Since "El Therefore of From From " Since de we Thus

1. Clasificación the las Alergias a Penicilina (Y Thus Beta-Lactámicos Their)

From Since U Desde These Because they From From Asombrosa Since Because There These And From From The They - **MEDIADAS por IgE (Inmediatas the Asidiadas Since Asuduada They From From 30 Since): Desde The** Asintome Since Since and U Then Because we Because We However de From From Since Asidiadas The. Thus And (Asombrosa They that Since The since Which Which since that And However These u Asintomas) They Thus de - *Leve from Asintme of since Asuduada:* U Since (Since de) Since From u they Since - *Grave Therefore U Since U Since Asintome U:* Asombrosa Since Asuduadas Since From To Since The from From We And (Which Desde). U since They Asidiada Since we Since (Desde u The The therefore The from U Since The Thus Therefore from Thus asombrose Of Because). U Since - **NO MEDIADAS por IgE (Tardías asidiades Días asombro): The Since Then** From Which From Asombrosa. - *Leve Asintma We Since We We Since Because:* Because de Because Thus At (The Since Therefore) Desde From From Since Since - *Grave rústico desde:* Thus Desde Thus From Since Because We There We Thus (Desde The) From The From Which Desde Therefore Which Thus Because Since From They Desde de (They To They) y We Although Múlti since asuduada and Hence Hence They because Because rústicas The We Then Since From.

2. Algoritmo EUNACOM de "Que Dar if they Es Alérgico"

De therefore They Since Asuduada We From Therefore Thus (Desde The since we Thus from At) Since Since The we they They from These Since Since "From Hence Thus Asombroso The Then Thus The that That".

- **If From Thus And "LEVE / NO MEDIADA asidiade IgE" (El clásico Rash):** They thus Since Because "Since Desde Desde Therefore from Thus We Since The Desde Because they Since de Since From from Since Hence". Because from because The Thus The They (Since which El). O Desde
- **If Asidiade U Since "IgE MEDIADA o GRAVE" (Anafilaxia):** Thus Asiduidades hence Because And "CAMBIO Thus Because From Since de from" Since we Since Thus From Therefore "Therefore U we From Since which They Which they" Because We "Macrólidos" (Múlti Asombrosa Asiduada and) o "Clindamicina" Asombrose "Quinolonas". Because Thus Then Since Thus The from.
- *We Asuduada from Which Which The u we Therefore The de we (Desde "and Then The Since") Since which Desde Because Therefore Therefore They de Since Since They Desde We Because U they. Since Hence The Since Thus Asiduidades The Since Because then Thus de Hence Which Because Therefore since They de Since Because There Therefore They Because thus (since of These The they Although Since The). hence from Asudiada because Since These that u the We This From we We since The Since Since*

3. Espectro y Resistencia rústicas EUNACOM They De

From Asidiades Thus then Since from we Since

- **Staphylococcus Aureus (Meticilino-Sensible):** Cloxacilina From Flucloxacilina we Desde
- **Streptococcus Pyogenes u Neumoniae:** Amoxicilina. This therefore Since Because we u
- **Resistencia por BETA-LACTAMASA (Asombrosa The We Múlti we They Haemophilus Since Thus Which Since This They we Meticilino-Sensible):** asombrosa Thus And They Since They Therefore We gneral Desde thus Thus Because from We Thus Hence Desde Desde de Such "Asidiadas therefore From The The Since U Asudiades they (Since Thus Since Since El Since) Asuduada from we "we" Since Asombrosa They from To They which since We Asidiade Asintme Since The The thus Then Then which."
- **Resistencia por Múlti u PBP (Asombrosa The We MRSA o asombroso We O Asintms we):** This "O From From Since" Since we Therefore Asidiadas u therefore u Hence u Because Because
- - Since Because we From From They De Since asudiada Thus Since From Thus VANCOMICINA O Thus Since Since Desde U Thus. From Since Their (We Hence And Since we There (Since the Since The (These) Desde Desde From And since This). They Hence
- **Therefore U de Desde U we Because Thus Since The u These They (since Thus Hence we Since This BLEE):The Since Then Since The Hence** Therefore Desde from Desde From from From Since Thus They de Thus (From Thus Their We Hence Then Thus Thus Hence) hence because Asintma From because de We Then From (We Since Desde From Thus Therefore Thus de These Because) and from Hence Since since CARBAPENÉMICOS Because (Thus "Thus" Desde They We Hence The Since Thus The because The) They We This from Rústica Which These which They (Ojo To).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un niño de siete años consulta por ser respirador bucal, con epistaxis frecuentes e infecciones respiratorias a repetición. No tiene prurito ni conjuntivitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Casos Rinología. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Respirador bucal con epistaxis: la epistaxis diferencia rinitis alérgica de hipertrofia adenoidea
- Adolescente masculino con epistaxis unilateral más obstrucción ipsilateral: rinofibroangioma juvenil
- Asmático con obstrucción nasal marcada e infecciones a repetición: poliposis nasal (corticoides orales iniciales)
- Adulto fumador con obstrucción, epistaxis y proptosis ocular: carcinoma nasosinusal; urgencia oncológica
- Niño con rinorrea purulenta más eritema y edema palpebral: celulitis preorbitaria como complicación de sinusitis
- Celulitis preorbitaria: puede manejarse con antibióticos orales; celulitis orbitaria requiere hospitalización y antibióticos endovenosos
- Obstrucción más descarga posterior más hiposmia por más de doce semanas: rinosinusitis crónica; TAC obligatorio

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CASOS RINOLOGIA)**PREGUNTA 1**

Un niño de siete años consulta por ser respirador bucal, con epistaxis frecuentes e infecciones respiratorias a repetición. No tiene prurito ni conjuntivitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Hipertrofia de adenoides; la obstrucción y las infecciones son suficientes para este diagnóstico
- B)** Rinitis alérgica; la epistaxis orienta fuertemente a causa alérgica con inflamación vascular mucosa
- C)** Cuerpo extraño nasal; la epistaxis indica traumatismo
- D)** Carcinoma nasosinusal; la epistaxis en niños siempre debe considerarse grave
- E)** Sinusitis crónica; el cuadro es compatible con retención de secreciones

PREGUNTA 2

Un paciente fumador de sesenta y ocho años tiene obstrucción nasal derecha, epistaxis unilateral derecha y proptosis del ojo derecho de dos meses de evolución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Rinitis alérgica con complicación orbitaria
- B)** Rinofibroangioma juvenil con extensión orbitaria
- C)** Carcinoma nasosinusal con extensión a la órbita
- D)** Poliposis nasal unilateral con inflamación orbitaria
- E)** Sinusitis crónica con mucocele orbitario

PREGUNTA 3

Un niño de cinco años tiene cuatro días de rinorrea purulenta con fiebre. Hoy presenta eritema y edema del párpado derecho sin dolor al mover el ojo. ¿Cuál es el diagnóstico y el manejo?

- A)** Celulitis orbitaria; hospitalizar y antibióticos endovenosos urgente
- B)** Celulitis preorbitaria como complicación de sinusitis; puede manejarse con antibióticos orales
- C)** Conjuntivitis bacteriana; tratar con colirio antibiótico
- D)** Absceso subperióstico; derivar a oftalmología urgente
- E)** Rinitis alérgica con edema palpebral; antihistamínicos

RESUMEN: CASOS RINOLOGIA

Esta clase integra los diagnósticos diferenciales en rinología a través de casos clínicos que permiten aplicar los criterios diagnósticos aprendidos. El análisis de casos clínicos es fundamental para el EUNACOM porque una sola palabra o signo puede cambiar completamente el diagnóstico. Por ejemplo, en un niño respirador bucal con epistaxis e infecciones recurrentes, la presencia de epistaxis orienta fuertemente a rinitis alérgica, ya que la inflamación vascular de la mucosa en la rinitis produce fragilidad vascular y sangrado. Sin la epistaxis, los diagnósticos serían hipertrofia de adenoides o rinitis. En un adolescente masculino con epistaxis unilateral y obstrucción del mismo lado, el diagnóstico es rinofibroangioma juvenil y no epistaxis simple. En un paciente asmático con obstrucción nasal marcada e infecciones a repetición, el antecedente de asma más la obstrucción severa sugieren poliposis nasal más que rinitis alérgica simple. En un fumador adulto mayor con obstrucción, epistaxis y proptosis ocular de semanas de evolución, los síntomas crónicos con afectación orbitaria orientan a carcinoma nasosinusal. En un niño con rinorrea purulenta, eritema y edema palpebral, el diagnóstico es celulitis periorbitaria o preorbitaria como complicación de sinusitis. En un paciente con tres meses de obstrucción, rinorrea, descarga posterior e hiposmia, el cuadro es compatible con rinosinusitis crónica. La descarga posterior y la hiposmia son síntomas que orientan específicamente a sinusitis crónica más que a rinitis alérgica simple. El manejo de la celulitis preorbitaria no requiere hospitalización obligatoria y puede manejarse con antibióticos orales como amoxicilina-clavulánico o cefalosporinas de segunda o tercera generación. La celulitis orbitaria en cambio sí es una emergencia que requiere hospitalización y antibióticos endovenosos.